

SONOFISIO

RUA SANTA ELZA, 418, VILA ADYANA
TEL - 3921-1001 / 99724-7053

08/10 16:00



Rua Professor Alfredo Vieira de Moura, 85
Vila Adyana - São José dos Campos - SP
Email - contato@silveirasjc.med.br
Tel: (12) 39226109 / 39179828 / 988666109

Paciente: Gabriel Souza França

SOLICITAÇÃO DE CPAP

Paciente com roncos e apnéia Grave - IAH: 30, COM IMPORTANTE DESSATURAÇÃO
Solicito adaptação para CPAP, com rampa, automático, umidificador e seguimento de adaptação.

Grata,

Dra. Priscila Leite da Silveira
Otorrinolaringologista
CRM 140.497

Priscila Leite Da Silveira
CRM 140497 SP

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: GABRIEL DE SOUZA FRANÇA

Sexo: Masculino

Data do Exame: 28-04-2025

Idade: 44 anos

Peso: 72 kg

Altura: 1,62 m

Médico Solicitante: DRA. CAMILA CARRARA YASSUDA
DALL'OCA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 28/04/2025 21:58 e finalizado às 29/04/2025 05:45.

A latência para início do sono foi de 2,5 min e a latência para o sono REM de 43,0 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 394,0 min, com eficiência do sono de 84,4 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 3,7 % de estágio N1, 39,2 % de estágio N2, 20,7 % de estágio N3 e 36,4 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 70,2 min. Ocorreram 131 despertares, sendo o índice de 16,8 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 199, sendo 19 apneias obstrutivas, 4 apneias centrais, 0 apneias mistas, 176 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 30,3 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 36,8 e o IDR durante o sono NREM foi de 26,6. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 30,3 (nº/h), sendo 3,5 apneia/h e 26,8 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 91%, a média de 91% e a mínima de 69%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 33,3 (nº/h), sendo que em REM foi de 53,1 (nº/h) e em NREM foi de 31,6 (nº/h). Permaneceu 13,2 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (9), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**30,3 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (**69%**);
3. Latência para o início do sono (**2,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (**43,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (**84,4 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares **16,8 n°/h** (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (**3,7 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (**39,2 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (**20,7 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (**36,4 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco moderado, e intenso constante, verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

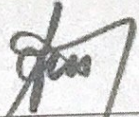
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57